PETJOURNEY · PORTAL DO PARCEIRO · MÓDULO CLÍNICO

Fluxo clínico — o que há de novo

Internação de ponta a ponta, alta hospitalar e um módulo que finalmente diz onde está o trabalho.

Data: 9 de setembro de 2026 **Para:** revisão antes de liberar para teste **Estado:** pronto para ser aberto e usado

Em resumo

Esta rodada entrega **três coisas**, e elas se somam: um módulo de internação completo — do leito ao boletim que o responsável recebe no celular —, o **encerramento** que faltava para esse ciclo fechar, e uma reforma de navegação que veio de uma reclamação direta: o fluxo estava confuso.

Nenhuma tela foi removida e nenhum caminho antigo deixou de funcionar. Tudo o que já existia — agenda, prontuário, receituário, documentos, vacinas, fila de espera — continua igual, no mesmo lugar.

8	4	3	691
leitos no mapa, com um fora de operação	abas de trabalho no paciente internado	desfechos de encerramento	testes automatizados passando

> **O diferencial desta entrega, em uma frase**
>
> A internação é o momento de maior angústia de quem deixou o animal na clínica, e hoje essa pessoa liga quatro vezes por dia. O **boletim automático** resolve dos dois lados: acalma quem está esperando e devolve o telefone para a recepção — com uma trava que nenhum concorrente tem, porque notícia grave nunca sai por notificação sem alguém ligar antes.

Novidade 1 · Internação, de ponta a ponta

Um bloco inteiro que não existia. Agora a clínica interna, medica, evolui, comunica e dá alta — sem sair do portal e sem planilha paralela.

Mapa de leitos

`Clínica › Internação`

Oito leitos numa grade — três gerais, dois felinos, uma UTI e dois de isolamento, um deles parado para manutenção. **O leito vazio ocupa espaço na tela**, porque "onde há vaga" é metade da pergunta que a clínica faz o dia inteiro.

Os cartões são marcados por **urgência, e não por gravidade**: um paciente crítico com tudo em dia não precisa piscar; um estável com duas doses atrasadas precisa. Marcar por gravidade deixaria o mapa vermelho onde nada há para fazer, e silencioso onde há.

Prescrição por horário e checklist de enfermagem

`abas Prescrição e Checklist`

A prescrição nasce já com os horários materializados, e cada horário vira uma linha que alguém marca. O checklist é agrupado por hora, com a linha do "agora" no meio da lista, e guarda **quem executou, a que horas e em que plantão**.

"Recusada" é um desfecho próprio, diferente de "pulada" — o gato que cospe o comprimido é uma informação clínica, não um esquecimento da enfermagem.

Evolução por plantão e passagem de turno

`aba Evolução · botão Passar plantão`

Uma evolução por paciente e por turno, com os sinais vitais do turno anterior à vista. Na passagem, as pendências são **congeladas** — recalculadas depois, a lista mostraria a pendência já resolvida pelo turno seguinte, e a passagem viraria uma página em branco, que é a forma mais educada de apagar responsabilidade.

A dose que cai **em cima da troca** é nomeada e trava a entrega do turno. É o caso mais banal da vida real: quem sai acha que quem entra vai dar, quem entra acha que já foi dada, e ela some.

Boletim ao responsável

`aba Boletim`

O texto é montado pelo sistema a partir do que aconteceu no período — estado, o que foi observado, doses do turno, temperatura — e a tela mostra **a conversa do celular do responsável ao lado**, para que quem envia veja o que a pessoa vai ler. Foto opcional e frequência configurável de 1 em 1 hora até 24 em 24, com o custo em mensagens por dia à vista antes de confirmar.

O **silêncio noturno junta em vez de pular**: o boletim que cairia às 3 da manhã sai às 7h. Pular deixaria um buraco de nove horas sem notícia.

A regra que dá nome ao módulo

Piora não sai por aplicativo. Quando o quadro piora, o boletim nasce **retido** e não sai até alguém registrar a ligação. O responsável está no trabalho, abre o celular e lê que o animal piorou, sem ninguém para perguntar o que aquilo significa — o que era diferencial vira a pior lembrança que ele tem da clínica.

A trava vive no servidor, e não na tela: nenhuma tela nova, nem uma integração futura, consegue contorná-la.

Cadastro de leitos

`Internação › Gerenciar leitos`

Quantos leitos a clínica tem é resposta dela, não do sistema. Cadastra, renomeia, tira de operação com motivo e devolve. Leito ocupado não sai de operação — **e a tela diz por quê, em texto**, em vez de mostrar um botão apagado que se lê como defeito. Leito que já recebeu paciente nunca se apaga: onde o animal ficou é a resposta que a clínica vai procurar seis meses depois.

Novidade 2 · A alta hospitalar

O ciclo começava e não terminava: o animal entrava no mapa de leitos e **não tinha por onde sair**. Além do registro que ficava por fazer, o mapa perdia o sentido — leito ocupado por um animal que já foi para casa é uma vaga que a clínica não sabe que tem.

Três desfechos, e não dois

DESFECHO	O QUE O RESPONSÁVEL RECEBE	POR QUÊ
Alta	Mensagem no aplicativo: o pet foi para casa	Fecha a conversa que os boletins abriram. Sem ela, a última coisa que a pessoa leu continua sendo o boletim das 14h — e ela fica com o celular na mão num sábado à noite sem saber se já pode parar de olhar.
Transferido	Nada. Comunica-se por telefone	O animal saiu vivo e o caso *continua* em outro lugar. Somar isso à alta faria a clínica ler como sucesso um encaminhamento às três da manhã para um centro de referência.
Óbito	Nada. Comunica-se por telefone	Quem recebe a notícia de que o animal morreu por notificação não volta a essa clínica — mesmo que tudo o que se fez antes disso tenha sido impecável.

Nos dois desfechos graves o sistema **recusa o encerramento** enquanto ninguém marcar que falou com o responsável por telefone. É a mesma regra do boletim de piora, aplicada ao outro extremo da internação — e ela mora no servidor.

A conferência de última hora

Antes de confirmar, a tela mostra o que fica registrado — permanência, doses dadas, recusadas ou puladas, boletins entregues — e avisa sobre dose pendente agora, dose futura que será suspensa e boletim que nunca saiu.

> **São avisos, e nunca travas**
>
> Um animal pode ir para casa com a dose das 18h no bolso do responsável, e um óbito acontece com um boletim retido na fila. Travar a alta nesses casos não faz a clínica resolver a pendência: faz o animal sair pela porta enquanto o sistema segue dizendo que ele está no leito R3. É assim que um mapa de leitos deixa de ser confiável.

A orientação de alta é **obrigatória nos três desfechos**. Na alta ela vai junto na mensagem que o responsável lê e segue em casa; no óbito e na transferência é o registro do que foi dito ao telefone — a única linha que responde, seis meses depois, ao que exatamente foi comunicado e por quem.

Novidade 3 · O módulo diz onde está o trabalho

Veio de uma reclamação: **o fluxo clínico está confuso**. A revisão não encontrou tela faltando nem tela sobrando — encontrou dez destinos numa lista plana, todos com a mesma aparência, e nenhuma forma de chegar a um paciente sem antes adivinhar em qual das quatro listas ele está agora.

Contadores de pendência no menu

`menu lateral`

Fila, Internação, Atividades e Vacinas passam a mostrar quanto trabalho está parado atrás delas. **Antes era preciso abrir as dez telas** para descobrir, várias vezes por dia. O contador soma só o que alguém precisa fazer — "38 atendimentos hoje" é rotina, "2 doses atrasadas" é pendência —, e cada número aparece em um lugar só.

Os dez destinos viraram quatro perguntas

`menu lateral`

Agora (Meu dia, Agenda, Fila) · **Em curso** (Prontuários, Internação) · **Pendências** (Atividades, Faltas, Vacinas) · **Análise** (Resumo). Nada saiu da lista: ela só deixou de exigir leitura inteira. A ordem antiga era a de construção — o Resumo, que se olha uma vez por semana, ficava acima da Agenda.

Busca em qualquer tela

`Ctrl + K · lupa no topo`

Digita-se o que se sabe — nome do animal, nome de quem responde por ele, telefone, ou o nome da tela — e a resposta é o destino. Antes, chegar a um paciente exigia saber *por onde* se chega até ele: Pacientes se veio ontem, Internação se está no leito, Agenda se tem horário hoje. Quem opera a clínica sabe o nome do animal; quase nunca sabe em qual das listas ele está.

A internação deixou de ser um sistema paralelo

`Clínica › Meu dia`

Um veterinário com cinco animais internados abria a tela inicial do próprio perfil e **não via nenhum deles**. Agora "Meu dia" traz os internados que cobram alguma coisa — e só esses —, o boletim retido sobe para o topo da tela como um botão que leva ao paciente, e o histórico do animal sabe que ele está internado agora.

Como testar em dez minutos

O percurso abaixo passa por tudo o que é novo. Os dados são de demonstração e o mundo é recriado a cada carga, então **nada do que for feito estraga nada**: pode marcar dose, enviar boletim e dar alta à vontade.

1. **Comece pelo menu.**
   Repare nos quatro blocos e nos números ao lado de Fila, Internação, Atividades e Vacinas. É a resposta a "onde está o trabalho?" sem clicar em nada.

2. **Abra "Meu dia".** `Clínica › Agora › Meu dia`
   No topo, a faixa vermelha do boletim retido. Clique nela — ela leva direto ao paciente que está esperando ligação. Volte e veja o bloco "Internados que cobram você".

3. **Vá ao mapa de leitos.** `Clínica › Em curso › Internação`
   Cinco dos oito leitos ocupados, a UTI tomada e um leito parado para manutenção com o motivo escrito. Procure o cartão com o selo de telefone: é o boletim preso, e agora ele tem dono.

4. **Abra o Tofu, na UTI.**
   É o gato com obstrução uretral que piorou. Vá à aba **Boletim**: a mensagem existe, está escrita, e o sistema recusa enviá-la. Registre a ligação e veja o envio liberar.

5. **Volte à aba Checklist e marque uma dose.**
   Repare que a linha guarda quem deu e a que horas, e que "recusada" é um botão diferente de "pulada". Desfazer devolve a linha ao estado anterior, sem deixar rastro pela metade.

6. **Registre uma evolução com piora.** `aba Evolução`
   Escolha uma gravidade pior que a atual e salve. A tela salta sozinha para o boletim — que nasceu retido. É a regra funcionando de ponta a ponta.

7. **Encerre uma internação.** `botão Encerrar internação`
   Escolha **Alta** e veja a conferência do que fica registrado. Depois troque para **Óbito**: a tela avisa que nada sai por mensagem e não deixa confirmar até a ligação ser marcada.

8. **Faça a passagem de plantão.** `Internação › Passar plantão`
   As pendências ficam congeladas na entrega, e a dose que cai em cima da troca aparece separada — é ela que trava a passagem enquanto não tiver dono.

9. **Aperte `Ctrl + K` de qualquer tela.**
   Digite "Bento", ou o nome de um responsável, ou um telefone. Digite "pendências" e veja que o rótulo do bloco também é termo de busca.

> **Se algo parecer lento ou falhar**
>
> É de propósito, e é controlável. O módulo simula a latência e a falha que a rede de uma clínica tem de verdade — inclusive o wi-fi da sala dos fundos que cai no meio de uma marcação de dose. Há um painel de demonstração no rodapé das telas para ajustar isso e para saltar direto aos casos difíceis já preparados.

O que ainda não existe

A lista honesta, para ninguém prometer o que não há. Vale a leitura **antes** de mostrar isto a um cliente.

O QUE A TELA MOSTRA	O QUE AINDA NÃO ACONTECE
Tudo	**Não há integração com servidor.** O módulo roda sobre uma camada de dados de demonstração — pacientes, agenda e internação são fictícios, e recarregar recria o mundo. A forma dos dados é a que a API vai ter.
"Enviar boletim ao responsável"	O envio é registrado e a conversa aparece na prévia do celular, mas **quem entrega a mensagem é o aplicativo**, que é outro projeto.
Assinatura eletrônica com código verificador	Hoje o código é um resumo simples; na API vira assinatura criptográfica.
Orçamento	Sai com os itens e os **valores em branco**: não há tabela de preços.
Plano de saúde e microchip do paciente	Não existem no cadastro; hoje são preenchidos à mão no documento.

O que recomendo construir em seguida

- **Consentimento na agenda, quando o tipo é cirurgia.** O termo é assinado *antes* do procedimento, e hoje só existe para reimpressão no fim. Na operação real, é o documento cuja ausência aparece só quando já houve um problema.
- **Resumo de alta imprimível.** A alta já registra a orientação e manda a mensagem; falta o papel que vai junto com o animal.
- **Alerta de medicação contínua no cabeçalho do paciente**, cruzado com o bulário — é o que evita a interação medicamentosa que ninguém lembrou de checar.
- **A internação encerrada na linha do tempo do paciente**, com desfecho e permanência: hoje são três dias de tratamento que saem do registro quando o animal vai para casa.

> **Um pedido, antes de considerar o menu resolvido**
>
> Os quatro rótulos — Agora, Em curso, Pendências, Análise — são as quatro perguntas que *nós* achamos que a clínica faz. Vinte minutos com alguém que opera clínica de verdade, olhando o menu e dizendo em voz alta o que procura, valem mais que qualquer teste automatizado. É a única verificação desta entrega que nenhum código consegue fazer.

Qualidade desta rodada: 691 testes automatizados passando, verificação de tipos limpa, build de produção gerado, e as quatro traduções (português, inglês, inglês britânico e espanhol) sem divergência.

O detalhamento técnico das mudanças de navegação e dos defeitos corrigidos está no relatório que acompanha este documento.